Cas ne justifiant pas un contact avec la coordination médicale

Sur la base de la convention CRf / BSPP
Mise en application par la DT 75 au 29/06/2026

Ces « cas de non contact » vous autorisent, dans certaines situations précisément listées et bien cadrées, à donner suite à votre intervention sans contacter la coordination médicale. Toutes les conditions mentionnées doivent être remplies sans exception possible, et tracées dans votre bilan. Lorsque le cas de non contact indique un transport en SAU, vous devez transporter vers les urgences de secteur. Si au cours du bilan de surveillance ou lors du transport, l'état de la victime s'aggrave et les critères ne sont plus remplis, vous devez alors contacter la coordination médicale.

L'existence de ces cas de non contact ne vous empêche aucunement de contacter la coordination médicale si vous en ressentez le besoin ou si vous avez un doute sur la situation ou le bilan. Vous pourrez ainsi bénéficier du conseil de l'opérateur ou du médecin.

Si vous avez un doute, pas de doute : contactez !

Le chef d'agrès est autorisé à ne pas contacter pas la coordination médicale en vue d'un bilan dans les cas qui suivent (cas 1 à 12):

1. **Absence de personne sur les lieux de l'intervention**, sauf si vous avez une équipe médicale au départ (le contact permet d'arrêter le renfort médicalisé).

2. ~~**Décès certain** sauf si vous avez une équipe médicale au départ (le contact permet d'arrêter le renfort médicalisé).~~ Le décès certain n'est plus un cas de non-contact. BSP 200.2 décès certain.pdf

3. **Il ne s'agit pas d'une victime** (selon la définition du chapitre 1 du BSP 200.2 Secours et soins d'urgence aux victimes). BSP 200.2 définition victime.pdf

4. **Crise de spasmophilie ou de tétanie** chez une victime ayant déjà ce type d'antécédent, sans signe respiratoire hormis une fréquence respiratoire élevée, sans facteur de risque ou antécédents cardiovasculaires, sans signe neurologique, transportée vers une structure médicale.

5. **Ivresse simple** (marche possible, chez une victime ne présentant ni trouble neurologique, ni traumatisme, prise en charge par la police, ou transportée en milieu hospitalier.

6. **Crise convulsive unique** chez une victime épileptique connue sous traitement, ayant récupéré un état de conscience normal (Glasgow 15), sans déficit moteur ou sensitif, transportée vers une structure médicale.

7. **Hypoglycémie resucrée** chez une victime sans antécédent cardiaque, sans douleur thoracique, sans sueurs persistantes, transportée vers une structure médicale.

8. **Epistaxis non traumatique** stoppée (n'avale pas le sang) chez une victime dont le traitement complet est connu et sans anticoagulants (liste jointe) et qui présente un bilan et des constantes normales. Cette victime peut être laissée sur place sans contact.

9. **Traumatisme simple** :
   - Suspicion d'entorse du coude, du poignet, d'un doigt, du genou, de la cheville, du pied ;
   - Suspicion de fracture simple isolée du coude, de l'avant-bras, du poignet, d'un doigt, du col fémoral, de la jambe, de la cheville, du pied ;
   - Suspicion de luxation d'épaule ;
   - Plaies simples et contusions de la tête, sauf globe oculaire, sans perte de connaissance initiale (PCI), sans anticoagulants (liste jointe) ;
   - Autres contusions ;
   - Plaies et brûlures simples ;
   - Plaies suturables et non délabrantes des membres, sans risque de lésions profondes.

Ces situations doivent respecter toutes les conditions suivantes :
- Douleur < 7/10 (ou EVS < 4)
- Cinétique faible
- Aucun déficit vasculo-nerveux
- Pas d'angulation importante
- Transport vers une structure médicale
- Âge > 1 an

10. **Relevage d'une personne impotente transportée**. Il doit s'agir d'une chute mécanique accidentelle, sans malaise, avec une durée au sol < 2 heures, sans point de compression ni escarre, sans douleur spontanée, sans déformation, sans signe d'AVC même transitoire (AIT).

11. **Relevage d'une personne impotente laissée sur place sans contact**. Il doit s'agir d'une chute mécanique accidentelle, sans malaise, avec une durée au sol < 2 heures, sans point de compression ni escarre, sans douleur spontanée, sans déformation, sans signe d'AVC même transitoire (AIT), sans signe respiratoire. La marche doit être possible sans douleur, les constantes strictement normales, le traitement complet connu, sans anticoagulant (liste jointe).

12. **Brancardage**.

Cette procédure est soumise aux conditions suivantes :
- Réalisation impérative d'un bilan complet ;
- Réalisation des gestes de secours appropriés ;
- Transport vers une structure médicale, sauf dans les cas 8 et 11 où elle peut être laissée sur place.

Les cas suivants doivent, quant à eux, faire l'objet d'un **contact obligatoire** :

- Présence de victimes non prises en compte par une équipe médicale sur les lieux ;
- Toute victime refusant ou ne nécessitant pas un transport à l'exception des cas 2 (décès certain), 8 (épistaxis non traumatique stoppée) et 11 (relevage LSP) ;
- Toute case rouge cochée sur la fiche bilan excepté :
  - pour le cas 4 : fréquence respiratoire > 20 ;
  - pour le cas 6 : PCI cochée, PA systolique souvent > 170 mmHg, PA diastolique souvent > 110 mmHg, FC souvent > 100 au début de l'intervention ;

    - pour le cas 7 : glycémie capillaire < 4,4 mmol/l ;
    - pour le cas 9 : EVS > 3 ou EN > 5 pour les traumatismes des membres.

- Tout départ dans le cadre d'une procédure rouge ou orange s'il n'y a pas d'équipe médicale au départ ;
- En cas de doute ou en présence de tout signe d'aggravation durant l'intervention.

Après avoir finalisé le bilan et lorsque l'attente au téléphone a dépassé 10 minutes après composition du numéro non urgent, il est permis aux chefs d'agrès de transporter en interrompant l'appel (cas 13) :

13. **Attente téléphonique supérieure à 10 minutes**. Ce cas est soumis à plusieurs conditions :

- Contact non urgent (les demandes d'équipe médicale, les détresses avérées, les douleurs thoracique typiques, les AVC sont donc exclus) ;
- Procédure blanche ou retour de procédure verte ;
- Cas relevant d'un transport vers un Service d'Accueil des Urgences (SAU) ;
- Pas de douleur thoracique ;
- Pas de trouble respiratoire.

Liste des anticoagulants

Comprimés	Principe actif		Injectables	Principe actif
Coumadine	warfarine sodique		Calciparine	héparine calcique
Eliquis	apixaban		Fragmine	daltéparine sodique
Lixiana	édoxaban tosilate		Fraxodi	nadroparine calcique
Minisintrom	acénocoumarol		Héparine	héparine sodique
Pradaxa	dabigatran étexilate mésilate		Innohep	tinzaparine sodique
Préviscan	fluindione		Lovenox	énoxaparine sodique
Sintrom	acénocoumarol		Orgaran	danaparoïde sodique
Xarelto	rivaroxaban			